

# WEEKLY REPORT



## 教學部 週戰報

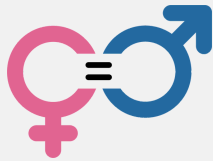
做夢的勇氣與創造360度醫學人生的能力

FRIENDLINESS



友善

EQUITY



公平

ARTISTRY



藝術

INSIGHT



洞察

### 年度回顧 | 2025，我們一起學會的事

這一年，我們用整年的時間，慢慢回答一個問題：在快速變動的醫療世界裡，我們想成為什麼樣的團隊？

我們在做的，不只是「工作」，而是在學習如何成為一個更好的醫療團隊。2025年的每一期週戰報，記錄的不只是活動與成果，而是在快速變動的醫療環境中，反覆思考一個問題：在科技加速、壓力加劇的時代，我們要如何讓醫療，依然以人為本？

從年初談友善、公平、藝術與洞察力開始，我們一次又一次回到「人」本身，回到臨床現場那一雙雙需要被看見的眼神，回到照護關係中那些需要細膩理解的時刻，回到教育現場裡彼此陪伴的溫度，回到團隊協作中那份相互信任的力量。我們學會，真正的專業不在於追求效率的極致，而在於讓每一個決策都能貼近真實的需求；科技的價值也不在於取代人力，而在於釋放出更多空間，讓我們能將時間與心力投注在更需要人性溫度的關懷之上。

這一年，我們一起走過偏鄉、走進病房、走入教育現場。從生成式 AI 至醫學教育，從第一性原理到心理安全，我們不只在「解題」，也開始練習「重新定義問題」。在這個過程中，我們也在不斷自我學習——學習如何傾聽不同的聲音，學習在錯誤中找到成長的養分，學習用更開放的心態面對未知。每一次的反思與調整，都讓我們更清楚自己想要前進的方向。

慢慢地，我們發現——能讓組織前進的，不只是制度與工具，而是一種敢說、敢試、敢修正、也願意彼此接住的文化。這種文化，需要每個人都願意走出舒適圈，在學習中保持謙卑，在協作中建立默契。

謝謝每一位在週戰報中出現、也在現場默默付出的你。是你們，讓這些文字不只是報告，而是一段正在發生的故事。走到年末，我們或許還沒有所有的答案，但我們學會如何一起提問、一起學習、一起前進。

願新的一年，我們繼續在不確定中保持好奇，在挑戰裡彼此信任，在醫療的每一個角落，走得更深，也走得更遠。



# 佛學與存在主義的生死觀

柯獻欽部長以「安生立命」為起點，引領我們穿梭於東西方兩種截然不同的生命哲學——相信「輪迴」的佛學智慧，與主張「斷滅」的存在主義思想。在這兩種迥異的視角之間，身而為人，究竟該如何自處？

## 直面終局：死亡作為存在的鏡子

死亡，是人生最確鑿無疑的終局(MEMENTO MORI)。海德格將人定義為「向死的存在」，唯有正視這份終極的恐懼，我們才能撥開虛妄的迷霧，活出真實的自己。因此，談論死亡的意義，不在於恐懼本身，而在於反思：如何「活得圓滿、走得安詳」，避免在生命盡頭才驀然驚覺——「我好像從未真正活過」。

## 佛教的生死觀：無我的輪迴

在佛教的宇宙觀中，死亡並非終結，而是業力(KARMA)的轉折點。所謂的「我」，不過是五蘊的短暫聚合，終將離散。那麼，究竟是誰在輪迴？佛教強調的是「因果相續」——輪迴的主體並非永恆不變的靈魂，而是識流的傳遞，如水面漣漪，如燈火相傳，雖無常流轉，卻因果自負。

## 存在主義的凝視：在荒謬中創造意義

相對地，存在主義直視「人死如燈滅」的終極虛無。既然宇宙不提供預設的意義，人類「對意義的渴望」與「宇宙的全然無意義」之間，便構成了深刻的「荒謬感」。面對這份荒謬，薩特提出「存在先於本質」——我們必須透過自由選擇來定義自己；卡繆則以西西弗斯為喻，認為真正的反抗，是在荒謬中保持清醒，持續行動，從而創造屬於自己的意義。

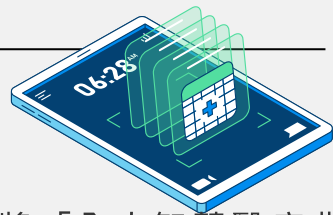
或許正是生命的有限性，才讓「此刻的擁有」顯得如此珍貴。與其焦慮地等待終局，不如從此刻開始熱烈地活著。誠如所言：「活得很盡致，才能死得很了然。」



## 殊途同歸：在有限中成就無限

無論是佛學中修行所謂的解脫，還是存在主義中認為擁抱荒謬，兩者看似路徑相反，實則相似——那便是：「時時想到死，但不找死、不怕死、不等死。」

## 智慧醫療運用在醫院經營管理



傅雲慶院長以臺中榮民總醫院(中榮)的轉型實踐為例，闡述如何將「全人智慧醫療典範」從願景化為現實。中榮連續四年榮獲美國《NEWSWEEK》「全球最佳智慧醫院」認證，2025年躍居全球第85名，成為臺灣唯一進入百大的國家級醫學中心。這份成就並非單純的技術堆疊，而是源於策略性與人文關懷並重的智慧化推動——聚焦於解決醫護人力短缺、急診壅塞及民眾就醫不便等臨床痛點，讓科技真正服務於人。



## 從組織變革奠定轉型基石

中榮於2021年3月成立「智慧醫療委員會」，下設九個專責小組，透過每三週一次的高頻率會議，確保智慧醫療項目持續推進。



更具突破性的是，中榮將原有的臨床資訊中心升格為全臺首創的「數位醫學部」，與資訊室緊密協作，從制度層面確保資訊技術與臨床需求深度融合。



中榮的智慧化發展聚焦四大面向：智慧醫療、智慧護理、智慧醫事及智慧管理。這不僅是為了降低醫護負擔、提升治療精準度與病人安全，更指向醫療平權與永續發展(ESG)的長遠願景。

在智慧護理方面，中榮於全院急性病房導入電子紙床頭卡，自動更新包含導管留置天數等26項關鍵資訊，每日節省相當於 **52.9** 位護理師的工時。這項創新連帶使護理人員離職率降至約 **6.0%**，遠低於全國平均的12.6%。與鴻海合作開發的「護理機器人 NURABOT」，預計可減少護理師30%的重複性工作，讓她們將時間回歸到更具溫度的照護互動——這也使得住院護理照護滿意度高達98.6%。

在智慧管理方面，中榮實施「精實管理策略」，將平均住院天數壓縮至 **4.7** 天，位居全國醫學中心前列。首創的「術前準備中心(PC)」，讓心導管、內視鏡或部分手術病人可當天報到入院，有效減少不必要的住院天數。同時，透過強化判科機制並嚴格執行**8小時內判科**規定，成功將急診轉住院但停留超過48小時的比率降至0%，從根本上緩解了急診壅塞的困境。



## 自動化檢驗重新定義效率

在智慧醫事領域，中榮建置亞洲首套全智能自動化軌道系統，連結24台檢驗儀器，每年減少約 **60,000** 次重複抽血。該系統大幅提升檢驗報告速度，急作檢體**60分鐘內達成率超過80%**，且透過手機APP讓病人隨時查看報告，人力成本降低達25%。

臺中榮總的智慧醫療轉型，將冰冷的IT系統轉化為有溫度的服務，有效回應臺灣醫療體系的深層挑戰。這些成就使其成為國內智慧醫院轉型的領航者，也持續在國際舞台上展現臺灣智慧醫療的卓越實力。

## 以AI精準診斷守護生命

在智慧醫療領域，中榮開發多項AI輔助診斷軟體，其中包括獲得TFDA認證的急性腎損傷(AKI)預測系統，能即時預測病人在24小時內發生AKI的機率，提醒醫護團隊及早介入。此外，利用胸腔X光影像分析預測骨質密度，準確率接近九成，為骨質疏鬆篩檢開闢新徑。

遠距醫療方面，中榮與中部地區26間醫療院所合作，運用5G救護車和居家心電圖監測，不僅提早偵測心房顫動，更創造顯著的ESG效益——累計減碳約 **27** 公噸，讓醫療創新與環境永續並行。



# 擁抱變革，小步快跑

分享者：教學部 英云

10月14日至15日我至北部參加了「Hello World Dev Conference 2025」的工作坊。課程中，講師們不斷提到一個關鍵字：「敏捷 (Agile)」。這個詞的出現頻率之高，讓我回來後特別深入研究了它的意涵。

我發現，「敏捷」不僅是軟體業的術語，更是一種應對「高度不確定性」的核心思維。傳統的工作方法常是「瀑布式」——花費數月進行鉅細靡遺的規劃，然後一步步執行，直到最後才交付成果。但「敏捷」主張的正好相反，它是「小步快跑，不斷修正」。敏捷的核心，是將一個大專案（例如導入一個新系統或新教案），切分成好幾個短週期。在每個短週期結束時，都必須產出一個「最小但可用的成果」，然後立刻投入測試、收集回饋，並在下一個週期快速調整方向。

這讓我深受啟發，並立刻聯想到我們的工作。



無論是導入AI提升行政效率、開發新的OSCE教案，還是建置內部線上系統，我們都處於一個需求不斷變動的環境——醫療知識持續更新、學員回饋不斷湧入，而院方政策也隨之調整。

如果我們採用傳統的「瀑布式」，可能花費半年打造一個自認完美的教案或系統，最終卻可能與使用者（第一線的醫師或學員）的實際需求脫節。

但如果我們嘗試導入「敏捷」思維：

- ❶ **系統開發**：是否能先推出「最核心的1個功能」（例如：會議室登記），讓同仁先用，再根據回饋逐步疊加新功能？
- ❷ **教案設計**：是否能先設計「10分鐘的核心模組」，讓學員實際演練，根據回饋立即修正，而不是等「完整的兩小時」都定稿才發佈？

在醫療與教育這個日新月異的領域，「敏捷」讓我們能更快地交付價值，並確保我們的努力是「做對的事」，而不只是「把事做對」，這是我參加此課程最大的收穫與反思。

美國NBA邁阿密熱火隊總裁-帕特·萊利

WHEN A GIFTED TEAM DEDICATES  
ITSELF TO UNSELFISH TRUST AND  
COMBINES INSTINCT WITH BOLDNESS  
AND EFFORT, IT'S READY TO CLIMB.

當一支有潛力的隊伍致力於無私的信任，結合直覺和勇敢與努力，它已具備好向上攀升。